

TRAUMA FÍSICO CRÔNICO INDUZIDO POR *PIERCING* LINGUAL: Abordagem reabilitadora com implante imediato e enxertia¹

Gustavo Leal de OLIVEIRA²

Glácio Mauro Ribeiro JUNIOR³

RESUMO

O uso de *piercings* orais tem se tornado cada vez mais frequente nas últimas décadas, especialmente entre adultos jovens, sendo frequentemente associado à estética e à expressão individual. Entretanto, apesar de sua popularização, diversos estudos têm demonstrado que tais dispositivos podem desencadear complicações importantes na cavidade oral, incluindo traumas mecânicos crônicos, recessões gengivais, perda óssea alveolar e comprometimento dentário progressivo. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo relatar um caso clínico de perda dentária associada a trauma físico crônico provocado por *piercing* lingual, abordando a conduta terapêutica empregada e sua relação com a literatura científica pertinente. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de caso clínico, desenvolvido a partir da análise clínica, imaginológica e terapêutica de paciente submetido à reabilitação implantossuportada após falha na manutenção de elemento dentário acometido por lesão endo-periodontal. O paciente apresentava histórico de utilização prolongada de *piercing* lingual associado a trauma repetitivo sobre incisivo inferior, evoluindo com mobilidade dentária, perda óssea vestibular e comprometimento periodontal severo, mesmo após tratamento endodôntico prévio. Diante do prognóstico desfavorável, optou-se pela realização de exodontia seguida de implante imediato associado ao uso de biomaterial e enxerto conjuntivo, visando restabelecimento funcional e estético da região acometida. Os resultados clínicos demonstraram adequada osseointegração, estabilidade peri-implantar e satisfatória recuperação estética após instalação da coroa protética definitiva. Conclui-se que o *piercing* lingual pode atuar como fator etiológico relevante para alterações periodontais, pulpares e ósseas progressivas, sendo o implante imediato associado a técnicas regenerativas uma alternativa terapêutica viável e previsível em casos de perda dentária decorrente de trauma físico crônico.

PALAVRAS-CHAVE: *Piercing* Lingual. Trauma Físico. Implante.

¹ Trabalho apresentado a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica do Curso de Implantodontia da Faculdade de Tecnologia do Ipê – FAIPE.

² Estudante do Curso de Implantodontia da FAIPE-MG, e-mail: gustavoleal.freitas@gmail.com.

³ Orientador do trabalho. Professor do Curso de Implantodontia da FAIPE-MG, e-mail: xxx

ABSTRACT

The use of oral *piercings* has become increasingly common in recent decades, especially among young adults, often associated with aesthetics and individual expression. However, despite their popularity, several studies have shown that such devices can trigger significant complications in the oral cavity, including chronic mechanical trauma, gingival recession, alveolar bone loss, and progressive dental compromise. In this context, the present study aimed to report a clinical case of tooth loss associated with chronic physical trauma caused by a tongue *piercing*, addressing the therapeutic approach employed and its relationship with the relevant scientific literature. This is a descriptive study, of the clinical case report type, developed from the clinical, imaging, and therapeutic analysis of a patient undergoing implant-supported rehabilitation after failure to maintain a tooth affected by endo-periodontal lesion. The patient had a history of prolonged use of a tongue *piercing* associated with repetitive trauma to a lower incisor, evolving with tooth mobility, vestibular bone loss, and severe periodontal compromise, even after previous endodontic treatment. Given the unfavorable prognosis, the decision was made to perform tooth extraction followed by immediate implant placement using biomaterial and connective tissue graft, aiming for functional and aesthetic restoration of the affected area. Clinical results demonstrated adequate osseointegration, peri-implant stability, and satisfactory aesthetic recovery after placement of the definitive prosthetic crown. It is concluded that lingual *piercing* can act as a relevant etiological factor for progressive periodontal, pulpal, and bone alterations, and that immediate implant placement combined with regenerative techniques is a viable and predictable therapeutic alternative in cases of tooth loss resulting from chronic physical trauma.

KEYWORDS: Tongue *Piercing*. Physical Trauma. Implant.

1 INTRODUÇÃO

A preservação dos dentes naturais constitui um dos principais objetivos da odontologia contemporânea, uma vez que a manutenção da dentição está diretamente relacionada à função mastigatória, à estética facial e à qualidade de vida dos indivíduos (Cavalcante et al., 2019). Em oposição, a perda dentária pode ocasionar alterações funcionais, comprometimento da mastigação, dificuldades fonéticas e impactos psicossociais relevantes, tornando essencial o

desenvolvimento de abordagens terapêuticas capazes de preservar ou restabelecer a integridade das estruturas orais (Dias et al., 2025).

Diversos fatores podem contribuir para a perda dentária, destacando-se principalmente a cárie dentária, as doenças periodontais e os traumatismos dentários. Entretanto, além dessas condições amplamente reconhecidas, outros fatores comportamentais e hábitos associados a modificações corporais também podem influenciar negativamente a saúde bucal, favorecendo o surgimento de alterações estruturais e inflamatórias nos tecidos dentários e periodontais (Marquezan et al., 2008).

Entre essas práticas, a utilização de *piercings* orais tem se tornado cada vez mais comum nas últimas décadas, especialmente entre adultos jovens (Masood et al., 2019). O *piercing* lingual destaca-se como uma das modificações corporais mais populares, sendo frequentemente associado à estética e à expressão individual. No entanto, apesar de sua ampla disseminação, essa prática pode representar um fator de risco significativo para diversas complicações na cavidade oral (Rojas-Rueda et al., 2025).

A presença de *piercings* na cavidade bucal está associada a diferentes alterações clínicas, incluindo fraturas dentárias, desgaste do esmalte, recessões gengivais, inflamações periodontais e aumento do acúmulo de biofilme. Tais complicações podem ocorrer principalmente devido ao contato repetitivo entre o dispositivo metálico e as estruturas dentárias, o que favorece o desenvolvimento de traumas mecânicos contínuos sobre os tecidos orais (Rojas-Rueda et al., 2025).

O impacto repetitivo provocado pelo contato constante do *piercing* com os dentes pode gerar microtraumas sucessivos, caracterizando um quadro de trauma físico crônico (Masood et al., 2019). Esse tipo de agressão mecânica pode comprometer progressivamente os tecidos de suporte dental, afetando tanto o ligamento periodontal quanto o osso alveolar, o que pode resultar em mobilidade dentária, perda de inserção periodontal e alterações estruturais nos elementos dentários envolvidos (Domingo et al., 2019).

Além do comprometimento periodontal, os traumas mecânicos repetitivos também podem provocar alterações na polpa dentária. Nessas situações, processos inflamatórios pulpares podem evoluir para quadros de necrose pulpar, tornando necessário o tratamento endodôntico como tentativa de preservação do elemento dentário. Contudo, quando há perda

significativa de suporte periodontal associada ao trauma crônico, o prognóstico do dente pode tornar-se desfavorável, mesmo após intervenções terapêuticas adequadas (Marquezan et al., 2008).

Em circunstâncias nas quais a perda óssea e a mobilidade dentária atingem níveis avançados, a manutenção do dente torna-se inviável, sendo a exodontia frequentemente indicada como alternativa terapêutica para evitar a progressão de processos inflamatórios e restaurar as condições de saúde bucal do paciente. Nesses casos, torna-se fundamental a adoção de estratégias reabilitadoras capazes de restabelecer a função mastigatória e a estética do sorriso (Oliveira et al., 2025).

Nesse contexto, os implantes dentários osseointegrados têm se consolidado como uma das principais alternativas para a reabilitação de áreas edêntulas. A previsibilidade clínica, as elevadas taxas de sucesso e a capacidade de restabelecer adequadamente a função e a estética tornam os implantes uma opção amplamente utilizada na prática odontológica contemporânea (Alvarenga et al., 2020).

Entre as diferentes abordagens terapêuticas disponíveis, a instalação de implantes imediatos, realizada no mesmo momento da extração dentária, tem sido amplamente discutida na literatura científica (Bahaa et al., 2024). Essa técnica apresenta diversas vantagens clínicas, como a preservação do rebordo alveolar, a redução do tempo total de tratamento e a possibilidade de manutenção das características anatômicas e estéticas da região afetada (Oliveira et al., 2025).

Entretanto, em situações nas quais há defeitos ósseos decorrentes de processos inflamatórios ou perda de suporte periodontal, a utilização isolada do implante pode não ser suficiente para garantir resultados funcionais e estéticos satisfatórios. Nessas circunstâncias, torna-se necessária a associação de técnicas regenerativas, incluindo o uso de biomateriais e enxertos ósseos, com o objetivo de promover a reconstrução do tecido ósseo e favorecer a estabilidade do implante (Araújo et al., 2019).

Além da regeneração óssea, a estabilidade dos tecidos moles ao redor dos implantes também desempenha papel fundamental para o sucesso estético e funcional do tratamento. Nesse sentido, o enxerto de tecido conjuntivo tem sido amplamente empregado para aumentar

o volume gengival peri-implantar, melhorar o contorno tecidual e reduzir o risco de recessões gengivais ao redor das próteses implantossuportadas (Coelho et al., 2026).

2 OBJETIVO

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo relatar um caso clínico de perda dentária associada a trauma físico crônico causado por *piercing* lingual, no qual foi realizada reabilitação por meio de implante imediato associado à enxertia óssea e enxerto de tecido conjuntivo, visando restabelecer as condições funcionais e estéticas da região afetada.

3 JUSTIFICATIVA

A perda dentária representa uma condição capaz de gerar importantes repercussões funcionais, estéticas e psicológicas para os pacientes, comprometendo a mastigação, a fonética e a harmonia do sorriso. Embora fatores amplamente conhecidos, como cárie dentária e doença periodontal, sejam frequentemente associados à perda de dentes, outras condições menos discutidas na prática clínica, como traumas mecânicos crônicos decorrentes de hábitos ou modificações corporais, também podem contribuir para o comprometimento das estruturas dentárias e periodontais.

Nesse contexto, a presença de *piercings* orais, especialmente na região lingual, tem sido apontada na literatura como um potencial fator de risco para o desenvolvimento de diversas alterações na cavidade bucal. O contato repetitivo do dispositivo metálico com os dentes pode provocar microtraumas contínuos, favorecendo o surgimento de fraturas dentárias, recessões gengivais, mobilidade dentária e, em situações mais severas, perda do elemento dentário. Apesar dessas possíveis complicações, ainda são relativamente escassos os relatos clínicos que descrevem detalhadamente a evolução desses casos e as alternativas terapêuticas adotadas para a reabilitação das áreas afetadas.

Diante dessa realidade, torna-se relevante a apresentação de casos clínicos que evidenciem as consequências do trauma físico crônico associado ao uso de *piercings* orais, bem como as estratégias terapêuticas empregadas para restabelecer a função e a estética dentária.

Nesse sentido, a reabilitação por meio de implantes dentários associados a técnicas de enxertia representa uma alternativa terapêutica importante, possibilitando a reconstrução das estruturas perdidas e a recuperação da qualidade de vida do paciente. Assim, a descrição e discussão desse tipo de abordagem contribuem para ampliar o conhecimento clínico sobre o manejo dessas situações na prática odontológica.

4 RELATO DE CASO CLÍNICO

Paciente R.C.S., sexo masculino, 44 anos, compareceu à clínica odontológica com queixa relacionada à mobilidade progressiva e desconforto no elemento dentário 31. Durante a anamnese, o paciente relatou histórico de utilização de *piercing* lingual por período prolongado, referindo hábito frequente de contato repetitivo do acessório metálico com os incisivos inferiores. O paciente não apresentava comorbidades sistêmicas, alterações hematológicas ou condições médicas relevantes associadas ao caso clínico.

Ao exame clínico intraoral, observou-se comprometimento periodontal do elemento 31, associado à mobilidade dentária e perda de tecido gengival na região vestibular (Figura 1). Segundo relato do paciente, anteriormente havia sido realizado tratamento endodôntico convencional como tentativa de manutenção do elemento dentário, entretanto, sem sucesso clínico, uma vez que houve persistência da lesão e progressão da mobilidade dentária ao longo do acompanhamento clínico.

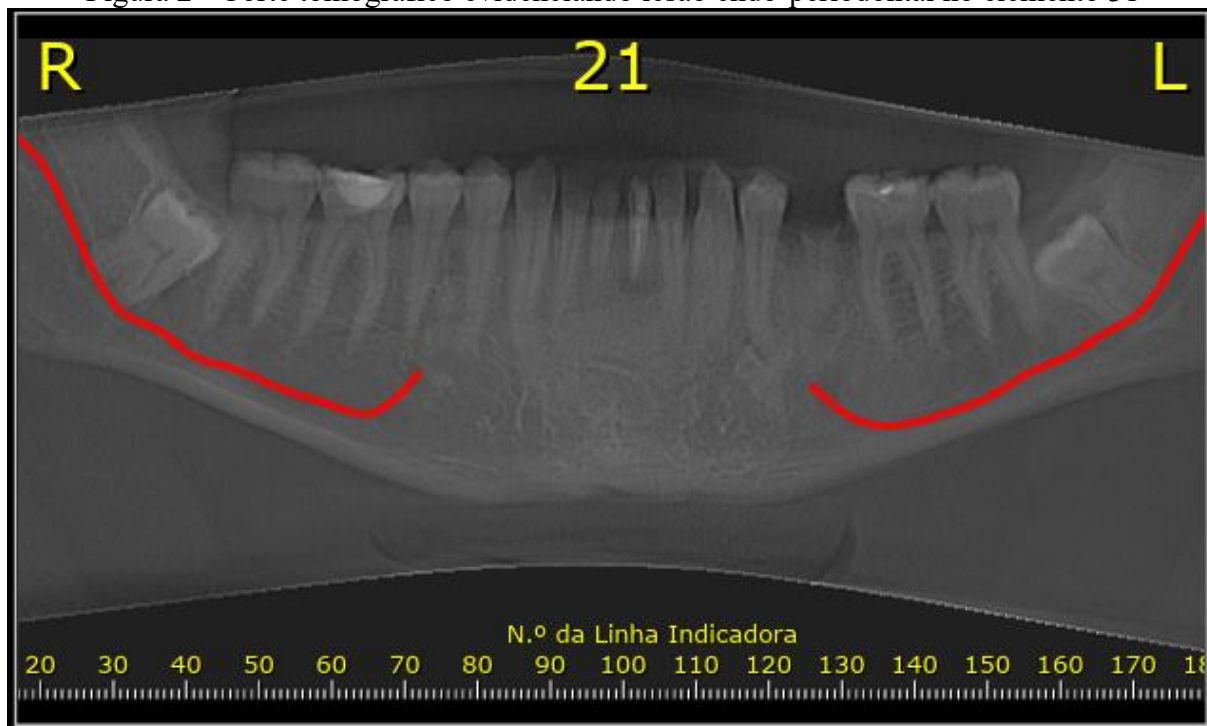
Figura 1 - Aspecto clínico inicial do elemento 31. Da esquerda para a direita: vista intrabucal e vista extrabucal lateral direita



Fonte: Autor (2026)

Diante dos achados clínicos, realizou-se solicitação de exame tomográfico computadorizado *cone beam* para avaliação detalhada da região afetada e planejamento terapêutico. A análise imaginológica evidenciou imagem hipodensa envolvendo a raiz do elemento 31, associada à reabsorção de toda a parede óssea vestibular e comprometimento parcial das paredes ósseas mesial e distal, apresentando características sugestivas de lesão endo-periodontal (Figura 2).

Figura 2 - Corte tomográfico evidenciando lesão endo-periodontal no elemento 31



Fonte: Autor (2026)

Além disso, a tomografia computadorizada possibilitou avaliar a extensão da perda óssea alveolar vestibular, evidenciando prognóstico desfavorável para manutenção do elemento dentário, mesmo após tratamento endodôntico prévio (Figura 3). A partir da correlação entre os achados clínicos e imaginológicos, considerou-se que o trauma físico crônico decorrente do contato repetitivo do *piercing* lingual com o elemento dentário possivelmente atuou como fator contribuinte para o agravamento do quadro clínico periodontal e pulpar.

Figura 3 - Reconstrução tridimensional da região mandibular. Da esquerda para a direita: vista frontal e vista lateral esquerda



Fonte: Autor (2026)

Considerando o comprometimento periodontal severo, a perda óssea vestibular e a persistência da mobilidade dentária, optou-se pela realização de exodontia do elemento 31 seguida de instalação imediata de implante dentário, associada à utilização de biomaterial e enxerto de tecido conjuntivo, visando restabelecimento funcional, estético e preservação dos tecidos peri-implantares.

O procedimento cirúrgico foi realizado em 07 de fevereiro de 2025, sob anestesia local, utilizando-se dois tubetes de anestésico (cloridrato de lidocaína associado à epinefrina) para a região receptora do implante e um tubete anestésico adicional para a área doadora do enxerto conjuntivo.

Inicialmente, realizou-se exodontia do elemento 31 por meio de técnica cirúrgica atraumática (Figura 4).

Figura 4 - Exodontia do elemento 31



Fonte: Autor (2026)

Em seguida, procedeu-se à instalação imediata do implante dentário UN III Cone Morse AR 3.5 x 13 mm na posição correspondente ao elemento 31, obtendo torque cirúrgico de travamento de 60 Newtons (Figura 5).

Figura 5 - Instalação do implante imediato.



Fonte: Autor (2026)

Após instalação do implante, realizou-se preenchimento da região com biomaterial, associado à utilização de membrana do enxerto conjuntivo do próprio paciente, devido ao defeito ósseo vestibular presente na região receptora.

O enxerto conjuntivo é proveniente da região de túber da maxila direita. A extração do tecido se deu com a utilização da lâmina de bisturi 15C. O enxerto foi posicionado na região receptora com objetivo de favorecer ganho volumétrico tecidual, estabilidade peri-implantar e melhora estética da região anterior mandibular.

A sutura da área doadora foi confeccionada utilizando fio de nylon 5-0 monofilamentar preto classe II, enquanto a estabilização do enxerto conjuntivo na região receptora foi realizada com fio azul de nylon extrafino, por meio da técnica de sutura simples (Figura 6).

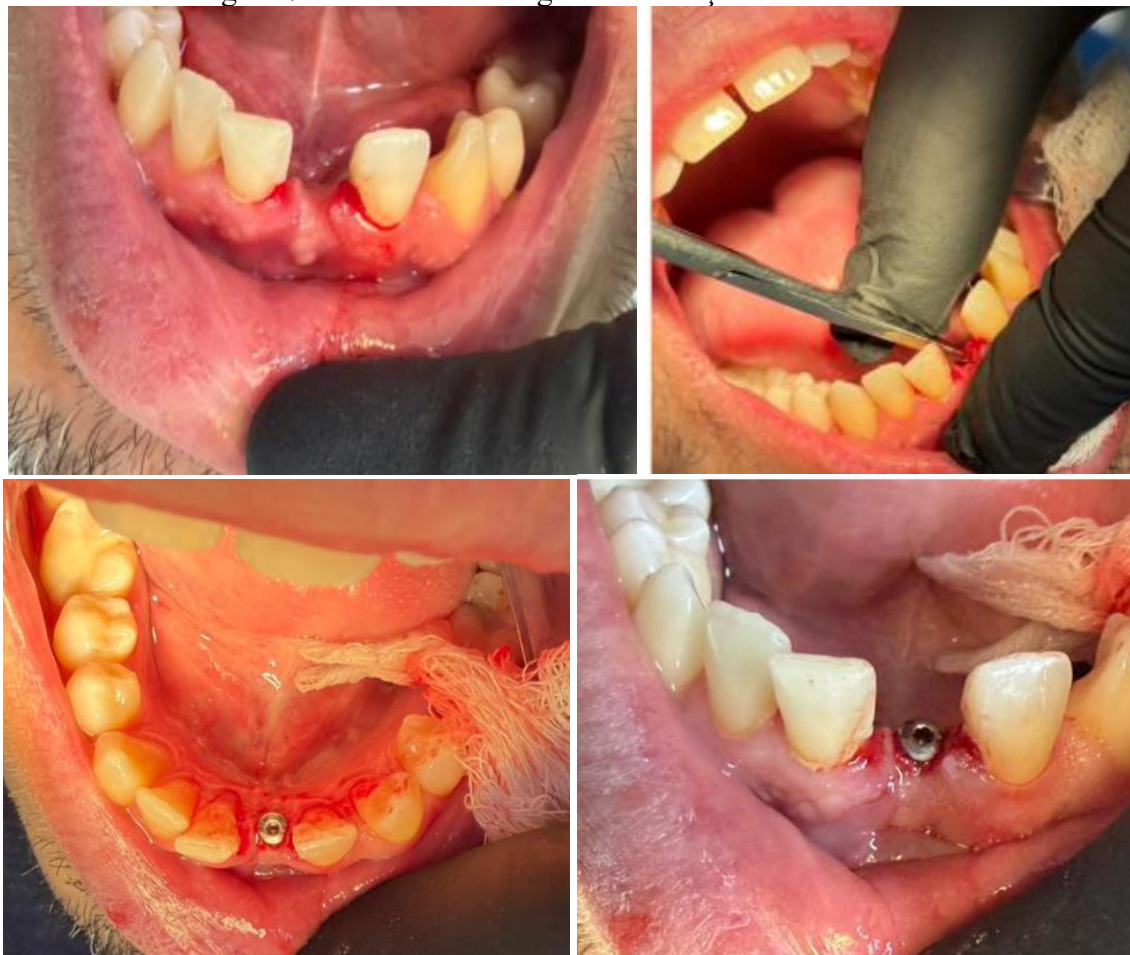
Figura 6 - Posicionamento do enxerto conjuntivo e sutura



Fonte: Autor (2026)

Após período de osseointegração, realizou-se procedimento de reabertura cirúrgica para instalação do cicatrizador peri-implantar, visando condicionamento tecidual para futura etapa protética (Figura 7).

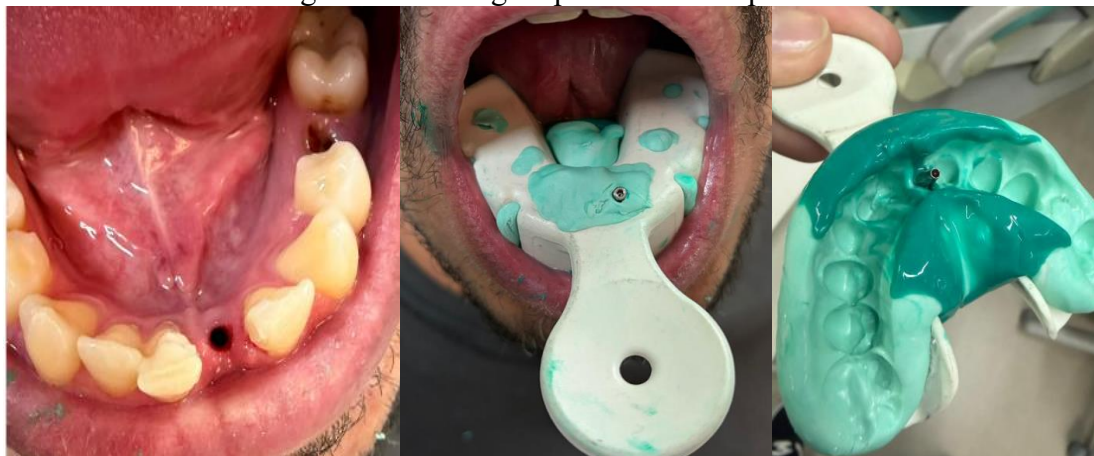
Figura 7 - Reabertura cirúrgica e instalação do cicatrizador



Fonte: Autor (2026)

Posteriormente, procedeu-se à moldagem de transferência do implante utilizando silicone de condensação Perfil®, com finalidade de confecção da coroa protética definitiva. Para reabilitação final, foi selecionada UCA Cone Morse AR CC 4.0 x 1.5, destinada à confecção de coroa em porcelana vítrea do tipo e.max (Figura 8).

Figura 8 - Moldagem protética do implante.



Fonte: Autor (2026)

Com a instalação da coroa protética definitiva, observou-se adequada integração estética e funcional da reabilitação implantossuportada à arcada dentária do paciente. Clinicamente, verificou-se estabilidade dos tecidos peri-implantares, adequado contorno gengival e harmonização do perfil de emergência protético, proporcionando restabelecimento satisfatório da estética do sorriso e da função mastigatória. O paciente demonstrou satisfação com o resultado obtido, especialmente em relação à recuperação estética da região anterior mandibular e à melhora funcional decorrente do tratamento reabilitador realizado (Figuras 9 e 10).

Figura 9 - Aspecto clínico final após instalação da coroa protética definitiva: Vista extraoral



Fonte: Autor (2026)

Figura 10 - Aspecto clínico final após instalação da coroa protética definitiva: Vista intraoral



Fonte: Autor (2026)

Também foi solicitada tomografia computadorizada *cone beam* de controle para avaliação pós-operatória da região reabilitada. O exame imaginológico permitiu observar adequado posicionamento do implante dentário, manutenção das estruturas ósseas peri-implantares e ausência de sinais sugestivos de alterações inflamatórias ou complicações associadas ao procedimento reabilitador, evidenciando condições compatíveis com adequado processo de osseointegração (Figura 11).

Figura 11 - Tomografia computadorizada final da região reabilitada



Fonte: Autor (2026)

5 DISCUSSÃO

A literatura científica demonstra que a preservação dos dentes naturais permanece como prioridade terapêutica na odontologia contemporânea, especialmente devido à sua relação direta com a manutenção funcional, estética e psicossocial dos indivíduos. Nesse contexto, Cavalcante et al. (2019) defendem que a perda dentária ultrapassa limitações mastigatórias, podendo comprometer também aspectos fonéticos, sociais e emocionais do paciente. Tal perspectiva corrobora o presente caso clínico, no qual a perda do elemento 31 repercutia diretamente na estética da região anterior mandibular e na qualidade de vida do paciente.

Embora cárie dentária e doença periodontal permaneçam entre as principais causas de perdas dentárias, Marquezan et al. (2008) ressaltam que hábitos comportamentais e modificações corporais também podem atuar como agentes etiológicos importantes para alterações periodontais e estruturais na cavidade oral. Nesse sentido, a utilização de *piercing*s orais, especialmente os linguais, tem sido amplamente relacionada ao desenvolvimento de complicações odontológicas progressivas, muitas vezes subestimadas clinicamente.

Masood et al. (2019) defendem que o *piercing* lingual se consolidou nas últimas décadas como uma das formas mais comuns de modificação corporal entre adultos jovens, sobretudo devido ao seu apelo estético e sociocultural. Entretanto, Rojas-Rueda et al. (2025) contrapõem a aparente inocuidade estética desse dispositivo ao evidenciarem sua associação com recessão gengival, acúmulo de biofilme, desgaste do esmalte e fraturas dentárias. No presente caso, observou-se que o contato repetitivo do acessório metálico com os incisivos inferiores atuou como fator desencadeante para o desenvolvimento de lesão endo-periodontal associada à perda óssea vestibular severa, reforçando o potencial destrutivo desse tipo de trauma mecânico contínuo.

Um dos aspectos mais relevantes do presente relato reside justamente no fato de o trauma não ter ocorrido de maneira aguda, mas sim de forma progressiva e cumulativa. Domingo et al. (2019) explicam que microtraumas sucessivos podem desencadear alterações graduais nos tecidos de suporte dentário, comprometendo ligamento periodontal, osso alveolar e estabilidade dental ao longo do tempo. Já Plessas e Pepelassi (2012) acrescentam que quanto maior o tempo de utilização do *piercing* lingual, maiores tendem a ser os danos periodontais observados clinicamente. Essa perspectiva dialoga diretamente com o caso apresentado, uma vez que a repetição constante do impacto metálico favoreceu progressiva reabsorção óssea vestibular e aumento da mobilidade dentária até tornar inviável a manutenção do elemento dental.

Outro ponto relevante refere-se à tentativa conservadora previamente instituída por meio do tratamento endodôntico. Conforme discutido por Marquezan et al. (2008), traumas mecânicos contínuos podem não apenas comprometer estruturas periodontais, mas também desencadear alterações pulpares importantes, incluindo necrose pulpar e inflamações persistentes. No presente caso, o tratamento endodôntico representou tentativa terapêutica

válida de preservação do elemento dentário; contudo, a persistência da perda óssea e da mobilidade demonstrou que o comprometimento periodontal associado já ultrapassava os limites de resolução exclusivamente endodôntica. Dessa forma, o insucesso clínico não deve ser interpretado como falha isolada da endodontia, mas sim como consequência da severidade do dano biomecânico e periodontal instalado.

Diante da progressão do quadro clínico, a exodontia tornou-se alternativa terapêutica inevitável. Oliveira et al. (2025) defendem que dentes com mobilidade avançada associada à extensa perda óssea frequentemente apresentam prognóstico desfavorável, tornando a remoção do elemento necessária para controle do processo patológico e posterior reabilitação funcional. No presente caso, a decisão pela exodontia foi diretamente sustentada pela associação entre comprometimento periodontal severo, reabsorção óssea vestibular e persistência da lesão endo-periodontal evidenciada tomograficamente.

Após a exodontia, optou-se pela instalação imediata de implante osseointegrado, abordagem amplamente discutida na literatura contemporânea. Bahaa et al. (2024) defendem que o implante imediato apresenta vantagens importantes, incluindo redução do tempo de tratamento, preservação parcial da arquitetura alveolar e menor morbidade cirúrgica quando comparado às abordagens tardias. Já Lee et al. (2021) acrescentam que, quando corretamente indicado e associado a adequado planejamento cirúrgico, o implante imediato pode apresentar taxas de sucesso e sobrevida semelhantes às observadas em implantes convencionais tardios. Tais evidências sustentam a conduta terapêutica empregada no presente relato.

Entretanto, um dos principais desafios encontrados no caso clínico relacionava-se justamente à presença de defeito ósseo vestibular decorrente da lesão instalada. Araújo et al. (2019) destacam que situações associadas à perda óssea alveolar significativa frequentemente demandam associação de biomateriais e técnicas regenerativas para favorecer estabilidade peri-implantar e manutenção volumétrica da região. No presente caso, a utilização do biomaterial não exerceu apenas função de preenchimento do defeito ósseo, mas atuou como estratégia biológica de reconstrução tecidual, visando proporcionar melhores condições estruturais para os processos de reparo e osseointegração.

Além do componente ósseo, a estabilidade dos tecidos moles também representava preocupação importante devido à perda gengival vestibular presente na região anterior

mandibular. Coelho et al. (2026) defendem que o enxerto conjuntivo desempenha papel fundamental no aumento de volume tecidual peri-implantar, favorecendo estabilidade gengival e melhora estética em regiões anteriores. De Angelis et al. (2021) complementam que a associação entre implantes imediatos e enxertos conjuntivos pode favorecer previsibilidade estética a longo prazo, especialmente em áreas com comprometimento tecidual prévio. Tais achados dialogam diretamente com o presente caso, no qual o enxerto conjuntivo foi empregado visando melhora do contorno gengival e estabilidade dos tecidos peri-implantares.

Outro aspecto relevante refere-se à integração entre diferentes especialidades odontológicas ao longo do manejo clínico. O caso evidencia que situações envolvendo trauma físico crônico decorrente de *piercing* lingual frequentemente exigem abordagem multidisciplinar, envolvendo endodontia, periodontia, cirurgia oral e implantodontia. Nesse contexto, o sucesso reabilitador observado não decorreu exclusivamente da instalação do implante dentário, mas sim da associação entre diagnóstico adequado, planejamento cirúrgico criterioso e utilização de técnicas regenerativas complementares.

Por fim, o presente relato reforça que o *piercing* lingual, embora frequentemente interpretado apenas como elemento estético, pode atuar como importante agente etiológico de alterações periodontais, pulpares e ósseas progressivas. O caso clínico apresentado demonstra que microtraumas repetitivos podem culminar em destruição significativa dos tecidos de suporte dental, exigindo abordagem reabilitadora complexa e multidisciplinar. Ainda, evidencia-se que a associação entre implante imediato, biomaterial e enxerto conjuntivo pode representar alternativa terapêutica viável para restabelecimento funcional e estético em situações de perda dentária associada a trauma físico crônico.

6 CONCLUSÃO

Conclui-se que o *piercing* lingual, apesar de frequentemente associado apenas a aspectos estéticos e culturais, pode representar importante fator etiológico para o desenvolvimento de alterações periodontais, pulpares e ósseas progressivas, especialmente quando associado a traumas mecânicos repetitivos sobre estruturas dentárias. O presente caso clínico demonstrou que o trauma físico crônico decorrente do contato contínuo do dispositivo metálico com o

elemento dentário foi capaz de desencadear comprometimento endo-periodontal severo, culminando em perda óssea vestibular significativa, mobilidade dentária avançada e consequente inviabilidade de manutenção do elemento 31, mesmo após tentativa terapêutica conservadora por meio de tratamento endodôntico.

Além disso, observou-se que a associação entre implante imediato, biomaterial e enxerto conjuntivo representou alternativa terapêutica eficaz para restabelecimento funcional e estético da região acometida, favorecendo estabilidade peri-implantar, manutenção volumétrica tecidual e adequada reabilitação protética. Nesse contexto, o caso reforça a importância do diagnóstico precoce das complicações associadas ao uso de *piercings* orais, bem como da atuação multidisciplinar no planejamento terapêutico desses pacientes.

Por fim, evidencia-se a necessidade de ampliação das discussões científicas acerca dos impactos biomecânicos e biológicos dos *piercings* orais sobre os tecidos dentários e periodontais, uma vez que muitos dos danos associados a esses dispositivos ainda permanecem subestimados clínica e academicamente.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, J. C. S.; MONTENEGRO, A. C.; TEMPONI, K. R. V.; PIMENTEL NETO, G. S. Preserva o Tecidual Peri-Implantar em Implante Imediato Posterior com Cicatrizador Personalizado: Relato de Caso Clínico. Revista Naval de Odontologia, v. 47, n. 1, 2020.

ARAÚJO, S. C. et al. Reabilitação com Instalação de Implante Imediato em Região de Molar com Abordagem Alternativa de Osteotomia: Relato de Caso. Rev. Odontol. Bras. Central, v. 28, n. 84, p. 23-25, 2019.

BAHAA, A.; BAHAA, A. M.; EL-BAGOURY, N.; KHALED, N.; IBRAHIM, A. M. Immediate Implants in Posterior Extraction Sites: A Case Series Applying the Dual-Zone Therapeutic Concept With a Three-Year Follow-Up. Cureus, v. 16, n. 2, e54890, 2024.

CAVALCANTE, F. T.; MOURA, C.; PERAZZO, P. A. T.; CAVALCANTE, F. T.; CAVALCANTE, M. T. Prevalência de dificuldade na mastigação e fatores associados em adultos de 20 a 59 anos em Patos, Paraíba, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 24, n. 3, p. 1015–1024, 2019.

COELHO, M. A. A.; LEITE, A. R. P.; PARENTE, C. A. R.; BEZERRA, A. L. D. Reconstrução de Tecido Mole em Região Peri-Implantar: Revisão de Literatura. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 8, n. 1, p. 302-326, 2026.

DIAS, V. B.; CASTRO, V. P.; COSTA, P. H. C. A. A relação entre a perda de dentes posteriores e a reabilitação oral funcional. *Rev. Nav. Odontol.* v. 52, n. 2, p. 1-6, 2025.

DOMINGO, M. G.; FERRARI, L.; AGUAS, S.; ALEJANDRO, F. S.; STEIMETZ, T.; SEBELLI, P.; OLMEDO, D. G. Citologia oral esfoliativa e corrosão de *piercings* metálicos: implicações nos tecidos. *Clinical Oral Investigation*, v. 23, p. 1895–1904, 2019.

MARQUEZAN, M.; SOUZA, L. T.; TANAKA, O. *Piercing* Oral: Beleza, Riscos e o Papel da Odontologia. *Rev. Fac. Odontol. Porto Alegre*, v. 49, n. 1, p. 12-15, jan./abr., 2008

MASOOD, M.; WALSH, L. J.; ZAFAR, S. Complicações orais associadas à liberação de íons metálicos em *piercings* orais: uma revisão sistemática. *European Archives of Paediatric Dentistry*, v. 24, p. 677–690, 2023.

OLIVEIRA, C. A.; CHIESA, C.; HOLANDA, J. K. A.; TANAKA, C. J.; ANGELETTI, P.; DIAS, R. O. Implante Imediato Pós-Exodontia com enxerto ósseo e uso de Cicatrizador personalizado: Relato de Caso Clínico. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 7, n. 10, p. 134-157, 2025.

RAJO, S.C.; ASSIS, L. C. F.; LAZARI, P. C.; SOUZA, J. A. C.; LELES, C. R. Reabilitação com Instalação de Implante Imediato em Região de Molar com Abordagem Alternativa de Osteotomia: Relato de Caso. *Rev Odontol Bras Central*, v. 28, n. 84, p. 23-25, 2019.

ROJAS-RUEDA, S.; CITRIN, N. S.; ANTAL, M. A.; GARCIA-CONTRERAS, R.; JURADO, C. A.; AZPIAZU-FLORES, F. X. Impact of tongue *piercings* on oral health: a narrative literature review. *Clinics and Practice*, v. 15, n. 9, p. 171, 2025.